ChatGPT

CRPD 금지에도 불구하고 정신의학에서 “엄격히 한정된” 화학적 강박 예외를 설계·정당화하는 논증과 근거

Executive summary

본 보고서는 장애인권리협약(CRPD) 체제에서 강제치료·강제입원 및 강박(물리적·화학적)을 “원칙적으로 금지”하는 해석이 강하게 전개되어 왔음에도, **임박한 중대한 위해(imminent serious harm)** 상황에서 **시간·목적·범위가 엄격히 한정된 화학적 강박(CR: chemical restraint)** 예외를 법·윤리·임상적으로 방어하려는 논증들이 어떻게 구성되는지 정리한다. 결론적으로, (a) CRPD 위원회의 “절대적 금지/폐지” 해석(특히 장애(손상) 기반의 자유박탈·강제치료 금지)과 (b) 다른 국제인권기구(자유권위원회 일반논평 35호 등) 및 다수 국내법·법원의 **필요성·비례성 기반 예외(최후수단·최단기간·절차적 보호)** 모델 사이에는 지속적인 규범적 긴장이 존재한다. [1]

사용자 초안에서도 2017년 특별보고관 보고서(A/HRC/35/21)와 자유권위원회 일반논평 35호(GC35)가 제시하는 상이한 접근(사실상 “해석적 균열”)이 핵심 문제로 제기되어 있으며, 이는 국제인권 체계 내부의 이른바 “Geneva impasse(제네바 교착)” 논의와 직접 연결된다. filecite turn0file0 L82-L96 [2]

본 보고서는 논문에서 활용 가능한 형태로 (1) CRPD 텍스트·권위 해석과 국가들의 유보/선언, (2) 좁은 예외를 정당화하려는 법·윤리 프레임(필요성·비례성, 비차별성 재구성, 생명·안전의 적극적 의무, ‘의지와 선호’ 기반 해석 등), (3) 급성 흥분·폭력 상황에서 약물 진정(rapid tranquillisation/응급 진정)의 효과·위험 근거, (4) 예외를 허용한다면 필수적인 안전장치(의사결정 기준, 문서화, 외부감독, 모니터링과 사후검토), (5) 인권 옹호자들의 비판과 반론, (6) 제한적 허용 모델을 둔 관할권·전문기구 사례 비교, (7) 정책 문안·결정 알고리즘(mermaid)까지 제시한다. [3]

CRPD와 국제인권법의 금지 구조와 경쟁 해석

CRPD는 조문 차원에서 (a) 장애인의 법적 능력(Article 12), (b) 신체의 자유·안전 및 “장애의 존재는 어떠한 경우에도 자유박탈의 정당화 사유가 될 수 없다”(Article 14(1)(b)), (c) 고문·잔혹·비인도적·굴욕적 처우 금지(Article 15), (d) 신체적·정신적 완전성 보호(Article 17), (e) 보건의료에서의 **자유롭고 충분히 정보에 기초한 동의**(Article 25(d))를 결합해 강제치료·강박을 강하게 문제화할 수 있는 텍스트를 제공한다. 특히 Article 12(4)는 법적 능력 행사와 관련된 조치가 **권리·의지·선호를 존중**하고 **비례성·최단기간·정기적 심사**를 포함해야 함을 명시한다. [4]

CRPD 위원회는 Article 14 지침에서 “기능 제한/정신사회적 손상(impairment)”에 근거한 자유박탈은 **예외 없이(absolute)** 허용되지 않으며, “위험성” 같은 추가 기준을 붙여도 장애(손상) 기반 구금이 정당화될 수 없다는 입장을 전개해 왔다. 지침은 협상 과정에서 ‘solely/exclusively(오로지)’ 같은 완화 문구를 넣는 제안이 배척되었고, 결국 **손상 + 위험성** 결합모델 역시 허용되지 않는다는 취지로 해석한다. [5]

또한 United Nations [6] 체제에서 특별절차·조약기구의 일부 권위 해석은 강제치료/강박을 “의학적 필요성”이 아니라 **인권침해의 구조(권력 비대칭, 차별, 폭력)** 로 파악한다. Dainius Pūras의 A/HRC/35/21은 강제치료·강제수용을 **“근절(end)”**로 향하는 방향에서 **의료적 강제의 급진적 감소**를 요구하며, 비자발적 조치를 정당화하는 법·윤리 논증을 “현상 유지(status quo)”로 기능시킬 위험을 경고한다. 다만 동시에 의료계의 “절대적 금지”에 대한 우려가 존재함을 인정하고, 폐지까지는 시간이 걸릴 수 있음을 언급한다. [7]

Juan E. Méndez [8] 의 고문특별보고관 보고서 계열(A/HRC/22/53 관련 인용)은 심리·지적 장애인을 대상으로 한 강제적·비동의적 조치(격리, 강박 포함)에 대해 "절대적 금지" 언어를 사용하며, 특정 상황에서는 고문 또는 비인도적 처우로 평가될 수 있음을 강조해 왔다. [9]

World Health Organization [10] 와 Office of the High Commissioner for Human Rights [11] 의 공동 지침("Mental health, human rights and legislation")도 정신건강 개입의 기초로 **자유롭고 정보에 기초한 동의**를 두고, 비자발적 입원·강제치료·격리·강박 등 강제 관행을 "종식"하는 방향이 권리 존중에 필수적이라는 취지로 정리한다. [12]

반면, 국제인권법에는 **비례성·최후수단·최단기간·절차적 보호**를 전제로 한 "제한적 허용" 모델도 분명히 존재한다. United Nations Human Rights Committee [13] 의 자유권규약(ICCPR) 일반논평 35호는 "장애의 존재 그 자체는 자유박탈을 정당화할 수 없지만", 개인을 심각한 위해로부터 보호하거나 타인에 대한 상해를 방지하기 위해 **필요하고 비례적인 경우**에 한해, **최후의 수단·최단기간**으로, **법률에 근거한 절차적·실질적 보호조치**와 함께 적용되어야 한다고 명시한다. [14]

이러한 경쟁 해석은 국가 실무에서 더 분명해진다. CRPD 비준과 동시에 다수 국가는 Article 12(법적 능력)의 해석에 관해 **유보/선언**을 통해 "대리결정(substitute decision-making) 완전 폐지" 해석을 수용하지 않는다는 입장을 표명해 왔다. 예컨대 Canada [15] , Ireland [16] , Uzbekistan [17] 등이 Article 12가 모든 대리결정의 폐지를 요구한다고 해석되는 범위에서는 계속 이를 허용할 권리를 유보한다는 취지의 문언을 남겼다. [18]

정리하면, 화학적 강박 예외를 논증하려면 "CRPD 위원회/특별보고관/WHO-OHCHR"이 대표하는 **폐지·절대금지** 흐름을 정면에서 다루면서도, 동시에 GC35 및 국내·지역 법질서의 **비례성 기반 예외** 전통과 국가 유보·선언을 근거로 "국제규범의 단일한 결론은 아니다"라는 점을 입증해야 한다. [1]

제한적 예외를 정당화하려는 법·윤리 논증의 계보

국제 논쟁을 "교착(impasse)"로 정리한 Wayne Martin [19] ·Sándor Gurbai [20] 는 UN 인권 체계 내에서 강제적 돌봄(coercive care)을 둘러싼 법적 논증들이 상충하며, 특히 '비동의(non-consensual)'와 '강제(coercive)'를 구분해 논의하고, 교착을 넘어서는 방안을 제안한다. 이 작업은 "예외를 만들자"는 단순 주장보다, **예외의 개념 설계(무엇을 금지하고 무엇을 남길 것인가)**가 핵심임을 보여준다. [21]

예외 정당화 논증은 대개 다음 4개의 축으로 구조화된다.

첫째, **권리 충돌 및 적극적 의무(positive obligations)** 프레임이다. 즉각적 폭력·자해 위험이 현실화된 상황에서, 의료기관·국가가 환자 및 타인의 생명·신체 안전을 보호할 의무를 진다는 주장이다. 이때 예외는 "치료를 강제할 권한"이라기보다 "임박한 중대한 위해를 막기 위한 최소한의 안전 조치"로 재규정된다. GC35는 바로 이 지점(심각한 위해로부터 보호/타인 상해 방지)에서 **필요·비례** 기준 하의 제한을 언급한다. [14]

둘째, **필요성·비례성·최소침해(least restrictive alternative)** 프레임이다. 이 논리는 결과적으로 "예외 허용"을 주장하더라도, 예외의 범위를 매우 좁게 만들도록 강제한다. 예컨대 영국의 정신무능력법은 "구속(restraint)"이 허용되려면 **손해 발생을 방지하기 위해 필요**하고 **손해 가능성과 손해의 중대성에 비례**해야 한다는 구조를 취한다. [22]

셋째, **비차별성 재구성('장애 특수법'이 아닌 '일반적 응급 원칙')** 프레임이다. CRPD 위원회가 특히 문제 삼는 것은 "정신사회적 손상(정신질환) + 위험성" 조합으로 특정 집단만을 대상으로 자유박탈·강제치료를 정당화하는 차별 구조다. 이에 대한 반대편 논증은 (a) 예외의 요건을 "진단/장애"가 아니라 (b) **상황적·기능적 기준(임박한 중대한 위해, 즉시적 대안 부재, 의사결정능력의 급성 손상 등)**으로 전환하고, (c) 적용범위를 "정신과"에만 묶지 않고 "응급의료 일반"의 긴급 예외(예: 심한 섬망, 저

혈당으로 인한 공격성 등)와 연속선상에 둔다. 이 논리의 핵심은 "장애 기반이 아니라 위험·필요 기반"이라는 점을 강조해 CRPD Article 14의 차별금지 취지와 충돌을 최소화하려는 시도다. [23]

넷째, **절차적 정당성(실체 요건 + 절차 요건)** 프레임이다. 헌법·인권법·의료법 영역에서는 강제적 개입이 완전히 배제되지 않더라도, 매우 강한 절차적 통제가 요구된다. 예컨대 Supreme Court of the United States [24]의 Washington v. Harper는 항정신병약 강제 투여가 허용될 수 있는 요건을 "심각한 정신질환 + 자신 또는 타인에 대한 위험 + 의료적 이익"으로 정리하고, 적법절차 요건을 결합해 판단하였다. Riggins v. Nevada는 재판 중 강제 약물 투여가 방어권과 적법절차를 침해할 수 있으며 필요성·대안 검토 등이 요구된다는 취지로 판시한다. Sell v. United States는 재판능력 회복 목적의 강제 약물 투여에 대해 더 엄격한 한계를 설정한다. [25]

이와 유사하게, Bundesverfassungsgericht [26] (독일 연방헌법재판소)은 정신과 강제치료가 기본권에 대한 중대한 개입임을 전제로, 관련 법규가 너무 넓은 재량을 허용하면 위헌이 될 수 있고, 강제치료 자체를 전면 부정한 것은 아니지만 **허용 요건을 매우 엄격하게 좁혀야 한다**는 취지의 판단을 내린 것으로 요약된다. [27]

유럽인권재판소(ECHR) 판례 흐름은 "의학적 필요성(therapeutic necessity)"을 강제 의료조치 정당화의 핵심 요소로 다루어 왔다(예: Herczegfalvy v. Austria). 이 접근은 CRPD 위원회식 "절대금지"와는 결이 다르지만, "필요성 입증의 엄격성" 및 "최소침해" 논증에 활용될 수 있다. [28]

한편, "CRPD 위원회의 Article 12 일반논평이 오히려 정신질환자의 다른 권리(건강권, 생명권 등)를 약화시킬 수 있다"는 비판도 예외 논증의 중요한 지적 자원이다. Melvyn C. Freeman [29] 등은 Article 12 일반논평의 급진적 해석이 현실에서 의료 접근성을 악화시키거나 보호 장치를 약화시킬 수 있다고 비판했다. Matthé Scholten [30]·Jakov Gather [31]는 Article 12의 특정 해석이 가져올 수 있는 불리한 결과를 분석하면서, 대안적 전진(예: 의사결정능력/기능 기반의 비차별 모델 등)을 제안한다. [32]

다만, 이 비판 문헌들이 곧바로 "화학적 강박 예외"를 지지한다고 단정할 수는 없다. 설득력 있는 논문을 위해서는, 비판 문헌이 제공하는 논점(권리 상충, 보호 공백, 절차적 정당성)을 바탕으로 **예외를 '정상화'하지 않으면서도 '응급 안전'에 한해 극단적으로 좁힌 설계**를 제시해야 한다. [33]

임상 근거: 효과·위험·허용 임계치

임상적으로 "화학적 강박"은 용어 자체가 이질적이다. 다수 임상지침은 'chemical restraint' 대신 **rapid tranquillisation(신속 진정/응급 진정)** 같은 표현을 사용하며, 목표를 "움직임 제한"이 아니라 "안전 확보를 위한 진정된 상태(가능하면 의사소통 유지)"로 설정한다. 예컨대 스코틀랜드 NHS 계열 지침은 rapid tranquillisation의 목표를 "수면/무의식이 아니라 **진정·안정(calmness)**"으로 기술한다. [34]

임상근거는 "예외를 허용할수록 안전이 증가한다"는 단순 도식이 아니라, **효과(위험 감소)와 위험(약물 부작용·과진정·호흡억제 등)의 교환(trade-off)**을 보여준다.

가장 널리 인용되는 실용적 RCT 중 하나인 브라질 정신응급실 연구(TREC Collaborative Group)는 IM midazolam과 IM haloperidol+promethazine을 비교해, 20분 시점에 "진정 또는 수면(tranquil or asleep)" 달성 비율이 midazolam군 89%, haloperidol+promethazine군 67%였다고 보고한다. 중대한 이상반응은 두 군 모두 1% 수준으로 보고되었고, 호흡억제 등은 관찰·역전이 가능했음을 기술한다. 다만 이 연구는 "약물 진정이 때로 불가피"함을 전제로 하면서도, 현장·자원·관찰 가능성에 따라 약물 선택이 달라질 수 있음을 논의한다. [35]

다른 RCT로는 David Barbic [36] 등(Annals of Emergency Medicine, 2021)이 응급실의 고도 흥분(RASS ≥ +3) 환자에서 IM ketamine(5 mg/kg)과 IM midazolam(5 mg)+haloperidol(5 mg) 단회 투여를 비교해, "적절한 진정(RASS ≤ -1)까지 시간"의 중앙값이 ketamine 5.8분 vs 병합군 14.7분으로 ketamine이 더 빠르다고 보고했다. 그러나 중대한 이상반응은 ketamine 12.5% vs 병합군 5.0%로 ketamine군에서 더 높게 관찰되었고, 신뢰구간이 넓어 불확실성이 남는다. 이 데이터는 "신속한 억제"가 곧 "위험 감소"로 직결되지 않으며, 약물별 위험 프로필이 다름을 보여준다. [37]

또한 강제적 조치 전체(격리·신체 강박 포함)의 위해를 다룬 체계적 문헌은, 특히 신체 손상·사망 위험이 "0"이 아님을 반복적으로 강조한다. Kersting 등(Frontiers in Psychiatry, 2019)은 강제조치 맥락에서 신체적 손상·사망에 관한 근거를 체계적으로 검토하며, 위해 사건의 존재 자체가 **예외를 논증하더라도 '위험 통제(모니터링·훈련·감사)'가 필수**임을 시사한다. [38]

임계치(threshold) 설정은 임상근거만으로 결정되지 않는다. 다만 지침들은 공통적으로 (a) 먼저 비약물적 진정(대화·환경 조정), (b) 자발적 약물 복용 시도, (c) 약물 선택 시 원인(정신병적 흥분, 섬망, 약물 intoxication 등) 고려, (d) 단회 처방·효과 평가 후 추가 투여, (e) 활력징후·의식수준 모니터링을 요구한다. [39]

아래의 간단한 "효과(진정 도달)" 차트는 위 두 RCT의 핵심 수치를 시각화한 것이다(서로 다른 연구·환경이므로 직접 비교가 아니라 '예시'로만 사용해야 한다). [40]

```
xychart-beta
    title "응급 흥분 상황에서 약물 진정 효과 예시"
    x-axis ["TREC: midazolam(20분 진정%)","TREC: haloperidol+promethazine(20분 진정%)","Barbic: ketamine(분)","Barbic: midazolam+haloperidol(분)"]
    y-axis "값(%, 또는 분)" 0 --> 100
    bar [89,67,5.8,14.7]
```

아래는 '중대한 이상반응'의 예시(연구 정의가 다르며, 표본이 작아 불확실성이 크다). [41]

```
xychart-beta
    title "중대한 이상반응 예시(%)"
    x-axis ["TREC: midazolam","TREC: haloperidol+promethazine","Barbic: ketamine","Barbic: midazolam+haloperidol"]
    y-axis "%" 0 --> 20
    bar [1,1,12.5,5.0]
```

요약하면, 임상근거는 "예외의 필요 가능성"을 뒷받침할 수 있으나, 동시에 (1) 예외의 적용 요건을 **임박·중대 위해**로 좁히고, (2) 약물 선택을 표준화하며, (3) 모니터링과 사후검토를 강제하지 않으면 오히려 위해를 확대할 수 있음을 보여준다. [42]

제한적 예외를 위한 안전장치 설계

화학적 강박 예외를 논증하는 논문이 설득력을 갖기 위해서는 "허용"이 아니라 **통제 가능한 '예외 체계(exception regime)' 설계**가 중심이 되어야 한다. 실무적으로는 기존의 '격리·신체 강박' 규범과 동일한 수준(혹은 그 이상)의 요건을 화학적 강박에도 적용해야 하며, 특히 **정의(definition)–결정 기준(criteria)–문서화(documentation)–감독(oversight)–모니터링(monitoring)–사후검토(review)**가 하나의 묶음으로 설계되어야 한다. [43]

핵심적인 안전장치의 최소 구성은 다음과 같이 “법적 요건(예: 필요성·비례성)”과 “임상 요건(예: 모니터링)”을 결합한다.

첫째, **엄격한 정의**. 미국 CMS·Joint Commission 계열 표준은 ‘화학적 강박’을 “진료를 위해 필요한 치료가 아니라, 행동을 통제/편의 목적(discipline or convenience)으로 사용되는 약물”로 정의한다. 이 정의는 “치료 목적의 표준 용량”과 “행동 통제 목적의 비표준 사용”을 구분하려는 시도이며, 예외를 설계할 때에도 (a) **치료 표준(standard treatment)** 범주와 (b) **제한 목적(restriction purpose)** 범주를 명확히 나누는 출발점이 될 수 있다. [44]

둘째, **실체 기준**. GC35식 모델을 따르려면, 예외는 (1) 장애/진단이 아니라 **임박한 중대한 위해**를 기준으로 하고, (2) **최후수단**이며, (3) **최단기간**으로 제한되어야 하고, (4) 법률상 절차적·실질적 보호장치가 있어야 한다. [14]

셋째, **의사결정능력·‘의지와 선호’ 고려의 구조화**. CRPD가 강조하는 ‘의지와 선호’(will and preferences) 논쟁에서, George Szmukler [45] 는 ‘의지와 선호’ 개념을 분석하며 위기 상황에서 허용 가능한 개입의 경계(예: 진정한 선호의 해석, 지원의무)를 논의한다. 예외를 주장하는 논문이라면, “응급 상황에서도 지원된 의사결정(supported decision-making) 시도”와 “사전의향/위기계획의 우선 고려”를 **법적 요건**으로 격상시키는 것이 필요하다. [46]

넷째, **모니터링 표준과 사후검토**. NICE의 폭력·공격성 지침은 rapid tranquillisation을 단회 처방으로 시작하고, 효과 평가 후 반복하며, 이후 활력징후·의식수준·호흡 등을 정기적으로 모니터링하고(일정 조건에서는 15분 간격), 제한적 개입 후 즉시 디브리핑 및 외부적 사후검토(72시간 내)를 요구한다. 이는 “예외를 허용한다면 반드시 이런 강도의 안전장치가 따라야 한다”를 보여주는 대표적 설계도다. [47]

다섯째, **대안 촉진(예외의 대체재를 제도화)**. 위기계획·정신의학적 advance directive·joint crisis plan은 강제 개입을 줄이는 대안으로 연구·정책에서 반복적으로 제시되어 왔다. Swanson 등(2008)은 psychiatric advance directives가 위기 개입에서 강제성을 줄일 수 있는 도구일 가능성을 논의한다. Henderson 등(2004) RCT는 joint crisis plan이 강제 입원·치료를 줄일 수 있음을 보고한다. 예외 논증은 이런 대안이 “있으면 좋은 옵션”이 아니라, **예외 허용의 조건으로서 국가·기관이 제공해야 하는 의무적 인프라**라는 점을 분명히 해야 한다. [48]

위 요소를 실제 결정 절차로 구현하기 위한 알고리즘(예시)은 아래와 같다. (논문에서는 용어를 “rapid tranquillisation/응급 진정”으로 두고, “chemical restraint”는 별도로 정의해 ‘치료 표준 vs 통제 목적’을 분리하는 전략이 흔히 사용된다.) [49]

```
flowchart TD
    A[위기 상황: 급성 흥분/폭력/자해 위험 인지] --> B{임박한 중대한 신체적 위해인가?}
    B -- 아니오 --> C[비약물적 개입 우선: 환경 조정·언어적 탈격화·관계 형성]
    C --> D{위기 완화?}
    D -- 예 --> E[평가·치료·위기계획 업데이트]
    D -- 아니오 --> F{자발적 약물/협력적 진정 가능?}
    F -- 예 --> G[자발적 투약 + 모니터링]
    F -- 아니오 --> H{대안(인력/공간/격리·신체강박 등)으로 위험 회피가 명백히 가능한가?}
    H -- 예 --> I[대안 시행(가장 덜 제한적인 것) + 지속 모니터링]
    H -- 아니오 --> J{응급 진정/화학적 강박 요건 충족? \n(최후수단·최단기간·의료적 필요성·약물금기 검토)}
    J -- 아니오 --> K[상급자/2차 의견 요청 + 즉시 재평가]
    J -- 예 --> L[단회 처방·투여(최소 용량) + 즉시 모니터링(호흡/의식/활력)]
    L --> M{안정(의사소통 가능·위험 감소)?}
```

```
    M -- 예 --> N[중단/감량 + 치료적 개입 전환]
    M -- 아니오 --> O[효과·부작용 평가 후 제한적 추가 투여(반복 금지 원칙) + 필요시 2차 의견]
    N --> P[사후조치: 기록·환자/직원 디브리핑·외부 검토(72시간 내)·데이터 보고]
    O --> P
    I --> P
```

비교: 관할권·전문기구의 제한적 허용 모델과 정의

아래 표는 "제한적 예외" 설계에 실무적으로 자주 인용되는 관할권·표준을 비교한 것이다. 표의 핵심은 **(a) 무엇을 '화학적 강박'으로 정의하는지, (b) 실체 기준이 무엇인지, (c) 절차·모니터링·감독이 어느 수준인지**다. [50]

관할권/기구	CR(또는 유사 개념) 정의·용어	예외 트리거(요지)	핵심 안전장치(요지)	1차 근거
United States [51] (CMS)	치료에 필요하지 않고 "discipline or convenience" 목적의 약물 = chemical restraint	원칙적으로 제한(시설 규정 하, 치료 필요성 중심)	정의 기반 통제(치료 vs 편의/통제)	[52]
United States [51] (Joint Commission)	행동 관리/자유 제한 목적의 약물도 restraint에 포함	BHC 표준에서 restraint 범주로 관리	조직 표준·보고·정책·교육	[53]
United Kingdom [54] (NICE)	"rapid tranquillisation" 사용(제한적 개입의 한 유형)	다른 개입 실패 시, 안전 위험 관리	단회 처방·효과 재평가·활력/의식 모니터링·사후 디브리핑·외부 리뷰·기록	[55]
United Kingdom [54] (MCA 2005)	restraint(구속) 일반 원칙	손해 방지 필요 + 비례성	필요성·비례성·최소 구속	[22]
Germany [56] (연방헌법재판소)	강제치료는 중대한 기본권 제한	강제치료 규정의 과도한 재량 제한(요건 엄격화)	실체 요건 좁힘 + 법적 통제	[27]
Canada [15] (SCC Starson)	강제치료는 능력·절차 기준과 연동	능력 평가가 핵심 쟁점	'최선의 이익'만으로 강제 불가 취지	[57]
South Korea [58] (정신건강복지법 제75조)	격리·신체강박 제한(화학적 강박 명문은 약함)	전문의 지시 + 위험 가능성 "뚜렷" + 다른 방법의 회피가 "뚜렷하게 곤란"	전문의 지시·최소화 원칙(조문상)	[59]

전문직·임상지침 비교(정신의학/응급정신의학)는 아래 표처럼 정리할 수 있다. 공통점은 "최후수단"과 "모니터링·문서화"지만, 약물 선택과 용어는 다르며, 이는 논문에서 "화학적 강박"을 어떻게 정의할지에 직접 영향을 준다. [60]

지침/단체	기본 원칙	핵심 메시지(예시)	1차 근거
National Institute for Health and Care Excellence [61]	제한적 개입은 안전을 위해 필요할 때만	RT 단회 처방, 활력/의식 모니터링, 사후 검토·보고 체계	[55]
British Association for Psychopharmacology [62] + National Association of Psychiatric Intensive Care and Low Secure Units [63]	de-escalation과 RT를 통합 지침으로 제시	탈격화는 협력적 과정, 약물은 그 다음	[64]
Project BETA(AAEP)	비강압적 탈격화 우선	약물은 원인에 맞춰 선택, 비약물적 접근 우선	[65]
American Psychiatric Association [66] (Resource Document)	seclusion/restraint는 최후수단	법적으로 "응급 안전 상황"에서만, 덜 제한적 개입 시도 후	[67]

한국 맥락에서는, National Human Rights Commission of Korea [68] 가 '격리·강박' 남용(전문의 지시 부재, 절차 위반 등)을 구체 사례로 지적하며 지도·감독 및 교육·재발방지를 권고해 왔다. 이러한 사례는 "예외를 법제화한다면 안전장치가 현실에서 작동하도록 강한 감독·기록·책임 구조가 필수"임을 역설적으로 보여준다. [69]

또한 National Center for Mental Health [70] 는 격리·강박 기록지 서식을 공개하고 있어, (비록 화학적 강박 서식은 별도로 정교화가 필요하더라도) **문서화의 표준화**라는 방향성은 국내에서도 실무 기반이 존재한다. [71]

인권 비판과 반론, 그리고 논문에 바로 쓸 수 있는 제안문

인권 옹호 진영의 핵심 비판은 보통 세 갈래다.

첫째, **차별**. "정신사회적 장애/정신질환"을 이유로 자유박탈과 강제치료를 허용하는 체계는 CRPD Article 14의 차별금지에 정면으로 반한다는 주장이다. CRPD 위원회의 Article 14 지침은 바로 이 점을 '절대적 금지'로 정리한다. [72]

둘째, **침해의 중대성(신체·정신 완전성, 자유로운 동의의 박탈)** . 강제 약물은 신체·정신의 완전성(Article 17)과 의료에서의 자유롭고 정보에 기초한 동의(Article 25(d))를 침해하며, 특정 상황에서는 잔혹·비인도적 처우(Article 15)로 평가될 수 있다는 주장이다. 고문특별보고관 문헌은 "절대적 금지" 언어까지 동원한다. [73]

셋째, **구조적 남용 가능성**. 인력·시설 부족과 권력 비대칭 속에서 '응급'의 문턱이 낮아지고, 강제 개입이 편의적으로 사용될 위험이 크다는 비판이다. A/HRC/35/21은 강제 결정이 구조적 실패의 산물일 수 있음을 지적하면서, 강제를 급진적으로 줄이고 종국에는 강제치료·강제수용의 종식을 지향해야 한다고 권고한다. [7]

이에 대한 반론(혹은 예외 설계의 논거)은 "강제의 정당화"라기보다 "응급 안전의 좁은 창(narrow window)"을 어떻게 다루는가로 정리하는 것이 설득력이 높다.

첫째, **국제인권법 내부의 다원성**. GC35는 장애 그 자체를 사유로 한 자유박탈을 금지하면서도, 심각한 위해로부터 보호/상해 방지를 위해 필요·비례적 제한(최후수단·최단기간·보호조치)을 명시한다. 국가 유보·선언 역시 Article 12 해석이 단일하

지 않음을 보여준다. 즉, “CRPD 위원회의 절대금지 해석”이 국제규범의 유일한 결론이라고 전제할 수는 없으며, 논문은 이 규범 충돌을 정직하게 드러내야 한다. [74]

둘째, **‘예외’의 설계가 차별을 재생산하지 않도록 하는 조건부 허용** . 예외의 실체 요건을 진단/장애가 아니라 “임박한 중대한 신체적 위해”로 두고, 적용 영역도 ‘정신과’가 아니라 ‘응급 안전’으로 일반화하면, 적어도 장애 기반 차별 논증을 약화시킬 수 있다. 이때 요건은 영국 MCA식 필요·비례성, 미국 헌법 판례식 위험·의료적 이익, 독일식 엄격한 법적 통제 원칙을 참조해 매우 좁힐 수 있다. [75]

셋째, **대안 인프라를 ‘예외 허용의 대가’로 법제화** . 강제 개입의 남용 가능성은 “예외가 존재해서”가 아니라 “대안이 없어서” 구조적으로 발생한다는 점을, A/HRC/35/21이 명시적으로 언급한다. 따라서 예외를 논증하는 논문이 진지하려면, 위기계획·advance directives·joint crisis plans 같은 대안이 실무에서 작동하도록 **제도적 의무(교육·인력·시설·데이터)**를 결합해야 한다. [76]

넷째, **임상근거의 ‘정직한 사용’**. 유럽정신의학계는 A/HRC/35/21이 정신의학을 과도하게 부정적으로 그리며 약물치료 근거를 무시한다고 비판하고 문서의 수정·대화를 촉구한 바 있다. 이는 “예외 논증”에서도 동일하게 작동한다. 즉, 약물 진정은 효과도 있지만 위험도 있으며, 위험 통제 장치가 전제되지 않으면 오히려 위해를 낳을 수 있음을 임상 데이터(예: ketamine의 빠른 진정 vs 더 높은 SAE 관찰)로 스스로 인정해야 한다. [77]

마지막으로, 논문에 그대로 전환 가능한 “정책 문안(초안)”과 “논증 구조”를 제시한다(예시이며, 실제 적용은 각국 법체계와 시설 규정에 맞춰 조정 필요).

정의(예시): “화학적 강박(chemical restraint)이란, 환자의 치료에 필요한 표준적 치료(진단과 적응증, 표준 용량·경로·모니터링 요건을 충족하는 치료)를 넘어, **주된 목적이 행동의 통제 또는 이동의 제한** 인 약물 투여를 말한다. 다만, 임박한 중대한 신체적 위해를 방지하기 위한 응급 안전 조치로서, 아래 예외 요건과 절차를 충족하는 경우에 한해 제한적으로 허용될 수 있다.” [78]

예외 요건(예시): (1) 임박한 중대한 신체적 위해(자해/타해)가 고도의 개연성으로 존재, (2) 비약물적 탈격화 및 자발적 협력 시도가 불가능하거나 실패, (3) 다른 덜 제한적 방법으로 위험 회피가 명백히 곤란, (4) 의료적 금기·상호작용·신체 상태 평가를 가능한 범위에서 시행, (5) 단회 최소용량, (6) 즉시 모니터링 및 시간 제한, (7) 사후 디브리핑·외부 리뷰·데이터 보고. [79]

문서화(예시): 위험 평가(행동/상황/시간), 대안 시도 내용, 환자의 의지·선호(사전의향 포함) 확인 노력, 약물 선택 근거(원인·금기), 투여 시각·용량·투여자, 모니터링 기록(호흡·의식·활력), 종료 기준과 종료 시각, 사후 환자·직원 디브리핑 요약, 외부 검토 결과 및 개선조치. [80]

끝으로, 남는 법적 긴장과 연구 공백을 논문에서 명시하는 것이 중요하다. CRPD 위원회의 절대금지 해석과 GC35/국내법의 비례성 예외는 여전히 조화되지 않았고(규범 충돌), “용어(chemical restraint vs rapid tranquillisation)” 자체가 관할권마다 달라 비교연구가 어렵다. 또한 급성 흥분에서의 약물 선택·부작용에 대한 RCT는 존재하지만, “권리 기반 안전장치(사후 검토, 옹호자 참여, 데이터 공개)가 실제로 강제 개입을 얼마나 줄이고 위해를 얼마나 줄이는지”에 대한 실증은 상대적으로 빈약하다. 이 공백을 인정하고, 예외를 주장하더라도 ‘예외의 축소·감시·폐지 지향성’(road map)을 함께 제시해야 국제법적 정당성을 방어할 여지가 커진다. [81]

---

[1] [5] [72] https://covenantswatch.org.tw/wp-content/uploads/2019/12/A7255-Annex.pdf
https://covenantswatch.org.tw/wp-content/uploads/2019/12/A7255-Annex.pdf

2 21 33 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6544564/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6544564/

3 13 16 17 19 20 42 43 47 55 56 60 79 80 https://www.nice.org.uk/guidance/ng10/evidence/full-guideline-pdf-70830253
https://www.nice.org.uk/guidance/ng10/evidence/full-guideline-pdf-70830253

4 68 73 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities

6 71 https://www.ncmh.go.kr/mentalhealth/board/boardView.do?bn=newsView&bno=&fno=106&gubun_no=9&menu_cd=04_02_00_04&no=8510&pageIndex=1&search_content=&search_item=
https://www.ncmh.go.kr/mentalhealth/board/boardView.do?bn=newsView&bno=&fno=106&gubun_no=9&menu_cd=04_02_00_04&no=8510&pageIndex=1&search_content=&search_item=

7 15 76 81 https://right-docs.uwazi.io/entity/c48rl5eyy7?file=1610441878980cvl1v0kcme8.pdf&page=15
https://right-docs.uwazi.io/entity/c48rl5eyy7?file=1610441878980cvl1v0kcme8.pdf&page=15

8 38 62 https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2019.00400/full
https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2019.00400/full

9 https://atlas-of-torture.org/entity/scso7h72ui4bb7i9kgdwe9udi?file=1535003856725ws3c3ls3kjviton52cwyiudi.pdf&page=15
https://atlas-of-torture.org/entity/scso7h72ui4bb7i9kgdwe9udi?file=1535003856725ws3c3ls3kjviton52cwyiudi.pdf&page=15

10 48 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2835342/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2835342/

11 26 37 41 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421004339
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421004339

12 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/WHO-OHCHR-Mental-health-human-rights-and-legislation_web.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/WHO-OHCHR-Mental-health-human-rights-and-legislation_web.pdf

14 23 31 45 61 63 70 74 https://uhr.humanrights.go.kr/pub/uhrstd/pair/line/742
https://uhr.humanrights.go.kr/pub/uhrstd/pair/line/742

18 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=iv-15&src=treaty&utm_source=chatgpt.com

22 75 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/6
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/section/6

24 67 https://www.psychiatry.org/getattachment/e9b21b26-c933-4794-a3c4-01ad427eed91/Resource-Document-Seclusion-Restraint.pdf
https://www.psychiatry.org/getattachment/e9b21b26-c933-4794-a3c4-01ad427eed91/Resource-Document-Seclusion-Restraint.pdf

25 54 https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep494/usrep494210/usrep494210.pdf
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep494/usrep494210/usrep494210.pdf

27 30 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2011/03/rs20110323_2bvr088209en.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2011/03/rs20110323_2bvr088209en.html

28 CASE OF HERCZEGFALVY v. AUSTRIA - HUDOC
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57781&utm_source=chatgpt.com

29 35 40 51 https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/959/1/adamsce4.pdf
https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/959/1/adamsce4.pdf

32 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26236004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26236004/

34 36 https://rightdecisions.scot.nhs.uk/tam-treatments-and-medicines-nhs-highland/adult-therapeutic-guidelines/mental-health/rapid-tranquilisation-guidelines/?searchTerm=rapid
https://rightdecisions.scot.nhs.uk/tam-treatments-and-medicines-nhs-highland/adult-therapeutic-guidelines/mental-health/rapid-tranquilisation-guidelines/?searchTerm=rapid

39 65 https://www.partnersincalm.com/pdfs/The_Psychopharmacology_of_Agitation_Consensus_Statement_of_the_AAEP_Project_BETA.pdf
https://www.partnersincalm.com/pdfs/The_Psychopharmacology_of_Agitation_Consensus_Statement_of_the_AAEP_Project_BETA.pdf

44 49 50 52 58 78 https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Transmittals/Downloads/R157SOMA.pdf
https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Transmittals/Downloads/R157SOMA.pdf

46 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6313688/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6313688/

53 66 https://digitalassets.jointcommission.org/api/public/content/1976b0291a284a8fa7a7b47d26808b5a?v=73722715
https://digitalassets.jointcommission.org/api/public/content/1976b0291a284a8fa7a7b47d26808b5a?v=73722715

57 https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/2064/index.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/2064/index.do

59 https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=900633960
https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=900633960

64 https://napicu.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/BAP-and-NAPICU-joint-guideline.pdf
https://napicu.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/BAP-and-NAPICU-joint-guideline.pdf

69 https://humanrights.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=24&boardNo=7611731&displayType=&menuLevel=&menuNo=&month=&page=&searchCategory=&sea
https://humanrights.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=24&boardNo=7611731&displayType=&menuLevel=&menuNo=&month=&page=&searchCategory=&searchType=&searchWord=&

77 https://www.europsy.net/app/uploads/2017/10/EPA-letter-to-UNOHCHR_final.pdf
https://www.europsy.net/app/uploads/2017/10/EPA-letter-to-UNOHCHR_final.pdf